EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS
N° EGRESO : 81277
SERVICIO : MEDICINA HSC
FECHA : 2024-03-25 09:51:00

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: ANGEL JAVIER ZAPATA ROMERO			RUN	: 19.486.739-5
F.Nac	: 03-12-1996	Edad	: 27 AÑOS, 3 MESES	Género	: Masculino
Dirección	: EL PEUMO 0963 11 DE SEPT			Comuna	: SAN CARLOS
Previsión	: FONASA B	Teléfono	: 945992459		
Fecha Ingreso	: 2024-03-19	Fecha Egreso	: 2024-03-25 09:51:00	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. A09.9-GASTROENTERITIS Y COLITIS DE ORTIGEN NO ESPECIFICADO

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

1) ENterocolitis 2° a C DIfficile en tratamiento
2) Sobreinfeccion de FQ en tratamiento
3) Asma
4) RInitis Cronica

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. A04.7-ENTEROCOLITIS DEBIDA A CLOSTRIDIUM DIFFICILE (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Paciente con antec descritos, consulta en SU el 18/03 por cuadro de una seamana de algia abdominal constipacion, de forma posterior con tos productiva y peak febril. A su ingreso se solicita AG covid (-), PCR 241,7; Gb 18,3; se evidencia cultivo del 12/03 de expectoracion (+) para SAMS, toxina C Difficcile (+).

TAC AP 18/03 -> presencia de material estercoraceo en 1/# distal de colon sigmoide, en eveuntual contexto de suboclusion intestinal de marco colonico, apendice sin alteraciones, a nivel pulmonar se describe antec de FQ con bronquiectasias pulmonares bilaterales, con signos de sobreinfeccion y atrapamiento aereo bilateral
Se decide hospitalizacion para manejo.

Durante estadia se inicia terapia ATB, con buena respuesta, sumado a terapia para tratamiento de FQ sobreinfectada, con aprameotrs inflamatorios en descenso en dias posteriores

Paciente HDN estable, sin dolor, con requerimiento de O2 suplementario para realizacion de KNT, sin episodios de nauseas y/o vomitos, con buena tolerancia a alimentacion VO, deposiciones (+), de consistencia mas solida en comparativa a dias previos, diuresis (+)

Examenes de lab -> crea 0,7; PCR 29,9; Na/K/Cl 140/4.8/103; Gb 15; Hb/Hcto 12.4/38; plaq 429000; segment 78%

Ex fisico -> Vigil; CLOTE; mucosas rosadas, hidratads, llene capilar < 2 segs
Cardiaco RR2T NAS
Pulmonar crepitantes finos en tercio superior de campo pulmonar, mayor a derecha
Abdomen BDI, RHA (+), sin megalias, sin signos de irritacion peritoneal
Extremidades sin edema, sin signos de TVP

Actualmente cursando su dia N° 5 hospitalizado, dia 5 de tratamiento ATB con vancomicina/cloxacilina, en condiciones de continuar hospitalizacion via HODOm

PLAN DE MANEJO:

1) HDN: Estable, sin conflicto
2) Ventilatorio: Estable, sin conflicto
3) Infeccioso: Actualmente cursando con enterolocitis por C. Difficcile, sumado a sobreinfeccion de FQ, con descenso de aprametros inflamatorios, se completara 10 dias de terapia con vancomicina oral, se realizada traslape de cloxacilina a cefazolina para completar terapia por 14 dias, se decide continuar hospitalizacion de paciente via HODOm, se solicitara control con examenes dentro de 48 hrs para seguimiento

INDICACIONES AL ALTA

1. Reposo relativo (aislamiento de contacto)
2. Regimen liviano a tolerancia
3. Vancomicina 250 mg mg c/6hrs VO (5/10)
4. Cefazolina 1 gr c/!2 hrs VO (5/14)
5. SAlbutamol 2 puff c/6hrs por AC
6. Brexotide 250/25, 2 puff c/12 hrs por AC
7. Tiotropio 2 puff al dia
8. Loratadina 10 mg al dia VO
9. Omeprazol 20 mg al dia VO
10. Calcio carbonato 1125 mg, un comp al dia VO
11. Paracetamol 500 mg, 2 comp c/8hrs VO
12. Metamizol 300 mg c/ 12hrs VO
13. KNT respiratoria dos veces al dia
14. Examenes de control 27/03
15. Traslado a HODOm para continuar con hospitalizacion

DANIEL EDUARDO ACEVEDO PEREIRA
MEDICO TRATANTE
18431829-6

JEFE SERVICIO